

TEMA 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

Dx: Específico Tx: Inicial Seg: Derivar

ASPECTOS ESENCIALES (HIGH YIELD)

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, choque, dolor isquémico, edema pulmonar agudo o alteración de conciencia) requiere cardioversión eléctrica sincronizada inmediata en taquiarritmias.
- En bradiarritmias sintomáticas o inestables, el tratamiento farmacológico inicial es Atropina 0.5 - 1 mg EV bolo, preparando marcapaso transcutáneo.
- Taquicardia de complejo QRS angosto ($<0.12s$) estable: 1° Maniobras vagales (Valsalva modificada), 2° Adenosina 6 mg EV bolo rápido.
- Taquicardia de complejo QRS ancho ($\geq 0.12s$) en adulto con antecedentes cardiovasculares debe manejarse como Taquicardia Ventricular hasta demostrar lo contrario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

"Mujer de 60 años con antecedente de estenosis mitral severa e hipertensión arterial, ingresa a urgencias por disnea de reposo y palpitations de inicio brusco hace 2 horas. Al examen físico: paciente soporosa, pálida y sudorosa; PA 82/40 mmHg, FC 145x' irregular, MP(+) con crépitos difusos en ambos campos pulmonares y soplo diastólico IV/VI en ápex. ECG confirma Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida."

Piensa en: Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida y descompensación hemodinámica aguda (Shock cardiogénico + Edema agudo pulmonar).

Conducta: Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con 120-200 Joules previa sedación rápida si la conciencia lo permite.

Definición y Concepto Fundamental

El manejo de urgencia en arritmias comprende el conjunto de medidas diagnósticas y terapéuticas inmediatas orientadas a estabilizar al paciente que cursa con un trastorno del ritmo cardíaco asociado a riesgo vital inminente o deterioro hemodinámico severo. La premisa fundamental en la medicina de urgencia no es el diagnóstico electrocardiográfico exacto inicial, sino la determinación del estado de perfusión tisular y la presencia de inestabilidad hemodinámica.

Fisiopatología de la Inestabilidad Hemodinámica

Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias severas alteran el gasto cardíaco. En las taquiarritmias severas (frecuencias $> 150x'$), el tiempo de llenado diastólico del ventrículo izquierdo disminuye drásticamente, lo que reduce el volumen sistólico, colapsa el gasto cardíaco y disminuye la perfusión de las arterias coronarias (que ocurre predominantemente en diástole). En las bradiarritmias severas (frecuencias $< 40x'$), a pesar de un volumen sistólico compensatorio, la frecuencia extremadamente baja es insuficiente para mantener el gasto cardíaco mínimo requerido por los órganos nobles.

Criterios Clínicos de Inestabilidad (Los 4 Signos Cardinales)

Ante cualquier arritmia en urgencias, debe buscarse activamente la presencia de al menos uno de los siguientes 4 criterios de inestabilidad:

- **Signos de Choque / Hipotensión:** Presión arterial sistólica < 90 mmHg, presión arterial media (PAM) < 65 mmHg, frialdad distal, llenado capilar lento (>3 segundos) u oliguria.
- **Alteración Aguda del Estado Mental:** Somnolencia, confusión, agitación psicomotora o síncope secundario a hipoperfusión cerebral aguda.
- **Isquemia Miocárdica Activa:** Dolor torácico opresivo de características anginosas o cambios isquémicos agudos en el ECG.
- **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** Congestión pulmonar franca (crépitos bibasales difusos, ortopnea, tercer ruido, edema pulmonar agudo en radiografía).



FÁRMACOS CLAVE EN MANEJO DE URGENCIAS EN ARRITMIAS

Fármaco	Indicación	Dosis / Vía	Precauciones / EUNACOM Tip
Adenosina	TPSV regular de complejo angosto estable	6 mg EV bolo rápido en vena antecubital + 20 ml SF	Contraindicada en asma severo. Causa rubor y pausa asistólica corta.
Amiodarona	TV monomórfica estable / FA descompensada	150 mg EV en 10 min, infusión 1 mg/min x 6h	Hipotensión arterial, bradicardia. Monitorizar QT.
Atropina	Bradiarritmia sintomática / BAV nodal	0.5 - 1 mg EV bolo (repetir c/3-5 min max 3mg)	Ineficaz en BAV infranodal (Mobitz II / BAV 3° alto).

PREGUNTAS EUNACOM DEL TEMA

Pregunta 11

Mujer de 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI en ápex. La conducta inicial más adecuada es:

- Administrar amiodarona endovenosa en bolo
- Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con BiPAP
- Reponer fluidos con suero fisiológico

D) Cardioversión eléctrica inmediata

E) Administrar furosemida endovenosa asociada a drogas vasoactivas

Respuesta Correcta: D

Paciente hemodinámicamente inestable (PA 85/35 mmHg) por taquiarritmia con edema pulmonar agudo. La indicación absoluta de primera línea es la cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

EUNACOM TIP

En el examen EUNACOM, si un paciente con arritmia tiene hipotensión o edema pulmonar, la respuesta correcta SIEMPRE es cardioversión eléctrica. No intente fármacos primero.

DATO CLAVE

Sincronizar el cardioversor con la onda R es vital para evitar descargar sobre la onda T y precipitar una Fibrilación Ventricular (fenómeno R sobre T).

MINSAL GES

El protocolo SAMU / Red de Urgencia exige monitor con parches de desfibrilación instalados antes del traslado de todo paciente arritmico inestable.

PERLAS CLÍNICAS

- En taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular se realiza DESFIBRILACIÓN NO SINCRONIZADA inmediata.
- La dosis de adenosina debe administrarse mediante técnica de dos llaves (bolo rápido de fármaco seguido inmediatamente de 20 ml de SF y elevación del brazo).
- En bradiarritmias por sobredosis de betabloqueadores el antídoto específico es el Glucagón EV.